探讨心理康复结合语言训练对脑卒中失语症患者语言功能的影响

连丽霜

【摘要】 **目的**　观察心理康复结合语言训练对脑卒中失语症患者语言功能的影响。**方法**　200 例脑卒中失语症患者，以随机数字表法分成研究组和对照组，每组 100 例。对照组给予语言训练，研究组给予心理康复结合语言训练。比较两组患者训练前后的不良情绪、康复依从性、语言康复评分以及康复效果。**结果**　训练后，两组患者焦虑、抑郁评分较训练前降低，且研究组焦虑评分 (49.58 ± 6.61) 分、抑郁评分 (49.15 ± 3.99) 分较对照组的 (54.17 ± 5.62)、(54.02 ± 4.74) 分更低；两组患者康复依从性、语言康复评分较训练前提高，且研究组康复依从性评分 (3.43 ± 0.11) 分、语言康复评分 (136.26 ± 22.42) 分较对照组的 (2.03 ± 0.34)、(110.08 ± 14.03) 分更高 (P<0.05)。研究组患者康复训练中显著改善率 36.00%、中度改善率 41.00% 较对照组的 11.00%、20.00% 更高，而轻度改善率 21.00%、无变化率 2.00% 较对照组的 59.00%、10.00% 更低 (P<0.05)。**结论**　脑卒中失语症患者中，开展心理康复结合语言训练指导，可显著减轻患者的不良情绪，提升患者的依从性，改善患者的语言康复功能，获得理想效果。

【关键词】 心理康复；语言训练；结合干预；脑卒中；失语症

DOI：10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2024.16.044

Exploring the effect of psychological rehabilitation combined with language training on language function in stroke patients with aphasia

LIAN Li-shuang. Dehua County Hospital, Quanzhou 362500, China

【**Abstract**】 **Objective**　To observe the effect of psychological rehabilitation combined with language training on language function in stroke patients with aphasia. **Methods**　A total of 200 stroke patients with aphasia were divided into a research group and a control group using a random number table method, each consisting of 100 patients. The control group was treated with language rehabilitation, and the research group was treated with psychological rehabilitation combined with language training. The adverse emotions before and after the training, rehabilitation compliance, and language rehabilitation score, and rehabilitation effect were compared between the two groups. **Results**　After the training, the anxiety and depression scores of the two groups were lower than those before the training; the research group had anxiety score of (49.58 ± 6.61) points and depression score of (49.15 ± 3.99) points, which were lower than (54.17 ± 5.62) and (54.02 ± 4.74) points in the control group. The rehabilitation compliance and language rehabilitation scores of the two groups were improved compared with those before the training; the rehabilitation compliance score of the research group was (3.43 ± 0.11) points and the language rehabilitation score was (136.26 ± 22.42) points, which were higher than (2.03 ± 0.34) and (110.08 ± 14.03) points of the control group (P<0.05). The significant and moderate improvement rates of rehabilitation training in the research group were 36.00% and 41.00%, which were higher than 11.00% and 20.00% in the control group; while the mild improvement and no change rates were 21.00% and 2.00%, which were lower than 59.00% and 10.00% in the control group (P<0.05). **Conclusion**　In stroke patients with aphasia, combining psychological rehabilitation with language training guidance can significantly reduce their negative emotions, improve their compliance, improve their language rehabilitation function, and achieve ideal effects.

【**Key words**】 Psychological rehabilitation; Language training; Combined intervention; Stroke; Aphasia

脑卒中是目前高发于中老年人群中的一种脑血管疾病，一般情况下是突然发病的，也是诱发老年人群严重肢体功能障碍或死亡的原因[1]。临床中实施早期的康复训练，对于改善患者的肢体、运动功能及神经功能具有促进作用[2]。而且脑部疾病除了常见的后遗症肢体功能障碍外，还可能出现失语症。失语症发生后，患者对语言、文字等符号的理解会产生障碍，患者正常的表达能力会受到损害，通常会出现发音不正常或表达不出自己意愿的情况[3]。临床上常采用常规治疗外的急性脑卒中后失语症候群的治疗方法，所以多采用语言训练的方式进行指导，但单一的治疗效果并不理想，很难达到预期[4]。本院自开展心理康复结合语

作者单位：362500　德化县医院

中国知网　https://www.cnki.net

言训练获得理想效果，现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准[5]：经 CT/ 磁共振成像 (MRI) 诊断为脑卒中；存在一定的脑卒中失语症；首次发病；未接受过类似康复训练指导；精神状态可配合相关康复指导；临床资料完整；知情同意。排除标准[6]：沟通障碍；精神异常；严重并发症；出血、感染者。选取本院 2020 年 1 月 ~2021 年 12 月收治的 200 例脑卒中失语症患者，以随机数字表法分成研究组和对照组，每组 100 例。其中研究组男 58 例，女 42 例；年龄 43.0~79.0 岁，平均 (58.43 ± 6.86) 岁。对照组男 59 例，女 41 例；年龄 44.0~78.0 岁，平均 (56.59 ± 7.14) 岁。两组一般资料差异无统计学意义 (P>0.05)，具有可比性。

1.2 方法 对照组给予语言训练：①练习发音：指导舌上、下、左、右各方向反复运动，并示范龇牙、鼓腮、嗑瓜子等动作，以练习舌伸缩及口腔肌肉协调。②发音练习：发 a、o、e 等韵母，后单字发音，再双音词、短句训练，如爷爷、奶奶、猴子、老鼠、香菜、白菜等词组，反复练习。③命名、复述：图解训练 – 图字训练 – 听字指图训练 – 命名训练 – 复述训练 – 循序渐进地训练说简单的句子，包括主谓宾和其他的结构。先从听懂训练画面的水杯、桌子、草莓、面包等高频词汇中选取。④会话练习：每周固定一次，由护理人员进行一对一的简单会话，专门针对患者进行会话练习。⑤认识与辨识训练：挂图可以读出某个图的名字，对应的图由患者在挂图中找出来说出名字即可。研究组给予心理康复结合语言训练。心理康复包括：①评估：根据患者的评估结果，对患者的不良情绪进行评估，有针对性地制定辅导方案。②治疗：请专业心理治疗师对重度抑郁症患者进行心理咨询，全部采取一对一的形式，开展心理咨询。心理疏导根据患者病情 30 min/ 次，1~3 次 / 周。③增强信心：患者之间的共同语言比较多，容易产生互动，所以平时多创造康复效果好的患者和康复信心差的患者交流，分享经验，使患者战胜疾病的信心得到提高。同时护士再对患者进行语言训练干预。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组患者训练前后的不良情绪、康复依从性、语言康复评分以及康复效果。不良情绪包括焦虑、抑郁，抑郁情绪采用抑郁自评量表 (SDS) 进行评分，包括 20 个项目，采用 4 级评分方式，>53 分即有沮丧情绪，分数越高表示沮丧情绪越严重。焦虑情绪采用焦虑自评量表 (SAS) 进行评分，包含 20 项，采用 4 级评分法，50 分代表焦虑状态的存在，分值越高表明患者的焦虑程度越高[7]。康复依从性以询问的方式进行：①间断性的训练；②出现遗忘现象的现象；③有自行中止锻炼的情况，待病情稳定后自觉中止锻炼；④当自觉病情恶化时，有自行停止运动的情况。有则为 0 分，无则为 1 分，分值越高表明患者康复依从性越好。语言康复评分[8]：根据中国康复研究中心汉语标准失语症检查表 (CRRCAE) 的规定进行失语检查。由听理解、复述、说、读音、读写、抄写、描写、听写、运算 9 个篇目组成，采用 6 等级评分法，5~6 分为正答，1~4 分为误答。康复效果包括显著改善 (CRRCAE 单项评分提高 50% 以上或者更多的项目评分提高 30%~50%)、中度改善 (2 项评分提高 20%~30%)、轻度改善 (单项评分提高 20%~30%)、无变化[9]。

1.4 统计学方法 采用 SPSS25.0 统计学软件处理数据。用均数 ± 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示计量资料中符合正态分布数据，采用 t 检验；以率 (%) 表示计数资料，采用 χ^2 检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者训练前后不良情绪、康复依从性、语言康复评分比较 训练后，两组患者焦虑、抑郁评分较训练前降低，且研究组焦虑评分、抑郁评分较对照组更低；两组患者康复依从性、语言康复评分较训练前提高，且研究组康复依从性评分、语言康复评分较对照组更高 (P<0.05)。见表 1。

2.2 两组康复效果比较 研究组患者康复训练中显著改善率、中度改善率较对照组更高，而轻度改善率、无变化率较对照组更低 (P<0.05)。见表 2。

表 1 两组患者训练前后不良情绪、康复依从性、语言康复评分比较 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	时间	不良情绪		康复依从性	语言康复评分
			焦虑	抑郁		
研究组	100	训练前	63.49 ± 3.63	64.01 ± 8.35	0.95 ± 0.22	84.23 ± 16.03
		训练后	49.58 ± 6.61[ab]	49.15 ± 3.99[ab]	3.43 ± 0.11[ab]	136.26 ± 22.42[ab]
对照组	100	训练前	63.05 ± 3.47	62.89 ± 6.47	0.98 ± 0.21	84.01 ± 15.94
		训练后	54.17 ± 5.62[a]	54.02 ± 4.74[a]	2.03 ± 0.34[a]	110.08 ± 14.03[a]
$t_{训练前组间}/P_{训练前组间}$			0.876/0.382	1.060/0.290	0.986/0.325	0.097/0.923
$t_{研究组训练前后}/P_{研究组训练前后}$			18.445/0.000	16.057/0.000	100.826/0.000	18.878/0.000
$t_{训练后组间}/P_{训练后组间}$			5.290/0.000	7.860/0.000	39.177/0.000	9.899/0.000
$t_{对照组训练前后}/P_{对照组训练前后}$			13.444/0.000	11.059/0.000	26.275/0.000	12.277/0.000

注：与本组训练前比较，[a]P<0.05；与对照组训练后比较，[b]P<0.05

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　两组康复效果比较［n(%)］

组别	例数	显著改善	中度改善	轻度改善	无变化
研究组	100	36(36.00)[a]	41(41.00)[a]	21(21.00)[a]	2(2.00)[a]
对照组	100	11(11.00)	20(20.00)	59(59.00)	10(10.00)
χ^2		17.383	10.402	30.083	5.674
P		0.000	0.001	0.000	0.017

注：与对照组比较，[a]$P<0.05$

3　讨论

脑卒中是常见与老年人群的脑血管意外疾病，其可引发较高的致残率。绝大多数的患者在出现相关的肢体、运动、语言障碍后，均需要接受康复训练指导，以帮助恢复肢体、运动功能，继而提升日常生活能力[10]。但在多种后遗症类型中，脑卒中后失语症的发生率也较高，其发生原因主要是患者对语言的感知、识别、理解、接受、组织运用和表达等方面的功能失调，使大脑半球的语言及其相关中枢受到损害[11]。这种症状的出现，不仅对患者的语言功能有影响，而且对患者的心理也有较大的负担[12]。并且目前对于言语障碍除了对原有疾病进行积极的治疗外，对于脑卒中后失语症还没有特效的治疗方法或药物，康复训练是唯一有效的方法，但是由于患者的心理情绪不好，而且大量的研究表明言语康复训练的效果对患者的健康心理有积极的促进作用，因此，言语康复训练对患者的健康心理有积极的促进作用[13-15]。本研究中，训练后，两组患者焦虑、抑郁评分较训练前降低，且研究组焦虑评分 (49.58 ± 6.61) 分、抑郁评分 (49.15 ± 3.99) 分较对照组的 (54.17 ± 5.62)、(54.02 ± 4.74) 分更低；两组患者康复依从性、语言康复评分较训练前提高，且研究组康复依从性评分 (3.43 ± 0.11) 分、语言康复评分 (136.26 ± 22.42) 分较对照组的 (2.03 ± 0.34)、(110.08 ± 14.03) 分更高 ($P<0.05$)。研究组患者康复训练中显著改善率 36.00%、中度改善率 41.00% 较对照组的 11.00%、20.00% 更高，而轻度改善率 21.00%、无变化率 2.00% 较对照组的 59.00%、10.00% 更低 ($P<0.05$)。由此认为，对患者在以语言训练中，施以针对性的心理康复指导，从根本上解决患者的不良情绪问题，可以提升康复训练的依从性。

综上所述，对脑卒中失语症患者开展心理康复结合语言训练，可显著减轻患者的不良情绪，提升患者依从性，改善患者的语言功能，获得理想效果。

参　考　文　献

［1］ 甘莉，杨馨，李利娟，等．朗读治疗法同步远程言语康复对脑卒中后失语症患者语言能力和生活质量的影响．中华物理医学与康复杂志，2023, 45(3):199–204.

［2］ 徐冬梅，刘华，袁建，等．基于脑神经可塑性的上肢康复机器人对脑卒中患者运动性失语症及认知功能的影响．中国老年学杂志，2023, 43(6):1363–1366.

［3］ 彭丽延，徐娟．基于动态评估的语言康复训练在脑卒中后失语症患者中的应用．中国卫生标准管理，2023, 14(16):179–183.

［4］ 李倩．认知功能训练治疗缺血性脑卒中后失语症的临床康复效果及对交流能力的影响．医学信息，2023, 36(13):111–114.

［5］ 李浩正，吴毅，胡瑞萍．经颅磁刺激结合功能成像在脑卒中后失语症康复中的应用研究进展．中华物理医学与康复杂志，2023, 45(7):646–650.

［6］ 孙沛，何小俊，李薇薇．公式化语言在脑卒中后失语症康复中的应用．中国康复，2022, 37(6):376–380.

［7］ 胡含波，何小俊，李薇薇，等．远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展．护理研究，2022, 36(18):3291–3294.

［8］ 李金燕，赵光标，李启金．语言功能康复治疗用于脑卒中失语症患者的临床效果．反射疗法与康复医学，2022, 3(13):87–89, 102.

［9］ 胡含波，何小俊，李薇薇，等．虚拟现实技术在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展．护理研究，2021, 35(9):1601–1604.

［10］ 吴丽丽．针刺联合言语康复训练对脑卒中后失语症患者的影响．实用中西医结合临床，2022, 22(2):117–119, 128.

［11］ 周秋敏，卢倩，陈文莉，等．镜像神经元康复训练系统不同模式对脑卒中后失语症患者语言功能的影响．中华物理医学与康复杂志，2022, 44(10):894–897.

［12］ 李鸿章，李彦杰，秦合伟，等．邵氏五针法联合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语症患者的临床研究．南京中医药大学学报，2021, 37(4):491–496.

［13］ 覃亮，李松，杨信才，等．微针介入康复训练对脑卒中后失语症的临床疗效分析．中国临床医生杂志，2021, 49(2):247–250.

［14］ 左红霞，吴红燕．以兴趣为导向的主题卡片在脑卒中后失语症患者语言康复训练中的应用效果．护理实践与研究，2021, 18(1):54–57.

［15］ 丁晔．基于动态评估的康复训练对脑卒中后失语症患者的疗效与生活质量的影响．护理实践与研究，2021, 18(9):1265–1268.

［收稿日期：2023–09–21］

中国知网　https://www.cnki.net